

# ADHD, a funkcjonowanie psychospołeczne

Uzależnienia, współchorobowość, przestępczość, edukacja, praca i rodzina  
*synteza dowodów z metaanaliz, badań kohortowych i analiz rejestrowych*

# Cel i zakres raportu

*ADHD jako zaburzenie samoregulacji; dlaczego jego konsekwencje wykraczają daleko poza klasę szkolną*

Kliniczny obraz ADHD obejmuje nieuwagę, impulsywność i nadruchliwość, ale jego funkcjonalne znaczenie wynika przede wszystkim z trudności w samoregulacji, planowaniu, hamowaniu reakcji i odraczaniu gratyfikacji, nawet przy prawidłowych lub wysokich zdolnościach intelektualnych.

1

### Uzależnienia

rozwój, utrzymywanie się  
i leczenie SUD

2

### Współchorobowość

depresja, lęk, ChAD, zab.  
osobowości

3

### Przestępczość

nadreprezentacja i wpływ  
leczenia

4

### Edukacja i praca

osiągnięcia, zatrudnienie,  
dochody

5

### Rodzina i koszty

relacje, rodzicielstwo,  
koszty społeczne

*A jaką rolę odgrywa leczenie ADHD w ograniczaniu tych ryzyk?*

# Charakter i jakość dostępnych dowodów

*Związek statystyczny / pewny efekt przyczynowy*

## Mocne dowody empiryczne

- Skuteczność leków w redukcji podstawowych objawów ADHD; wiele RCT i metaanaliz sieciowych
- Krótko- i średnioterminowa poprawa funkcjonowania w warunkach kontrolowanych

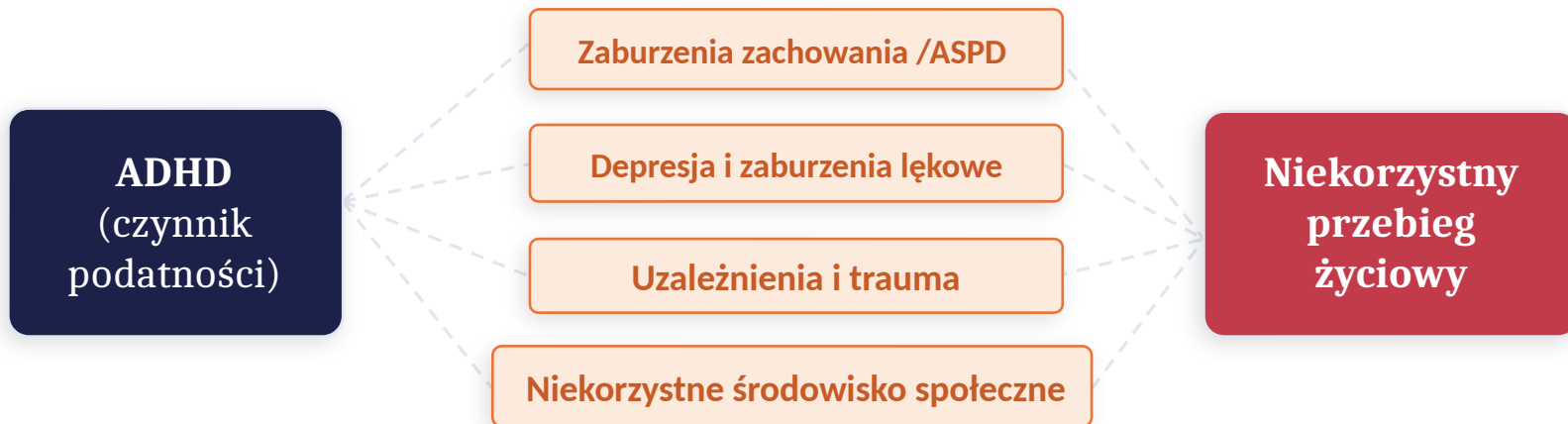
## Dowody obserwacyjne

- Uzależnienia, przestępczość, śmiertelność, koszty; głównie badania rejestrowe i kohortowe
- Duża liczebność i porównania okresów leczenia/braku leczenia u tych samych osób - ale bez pełnej eliminacji czynników zakłócających

Współchorobowość (zaburzenia zachowania, depresja, trauma, osobowość antyspołeczna, warunki społeczne) może współtworzyć ryzyko i jednocześnie pośredniczyć w jego związku z ADHD

# ADHD jako czynnik podatności, nie jedyna przyczyna

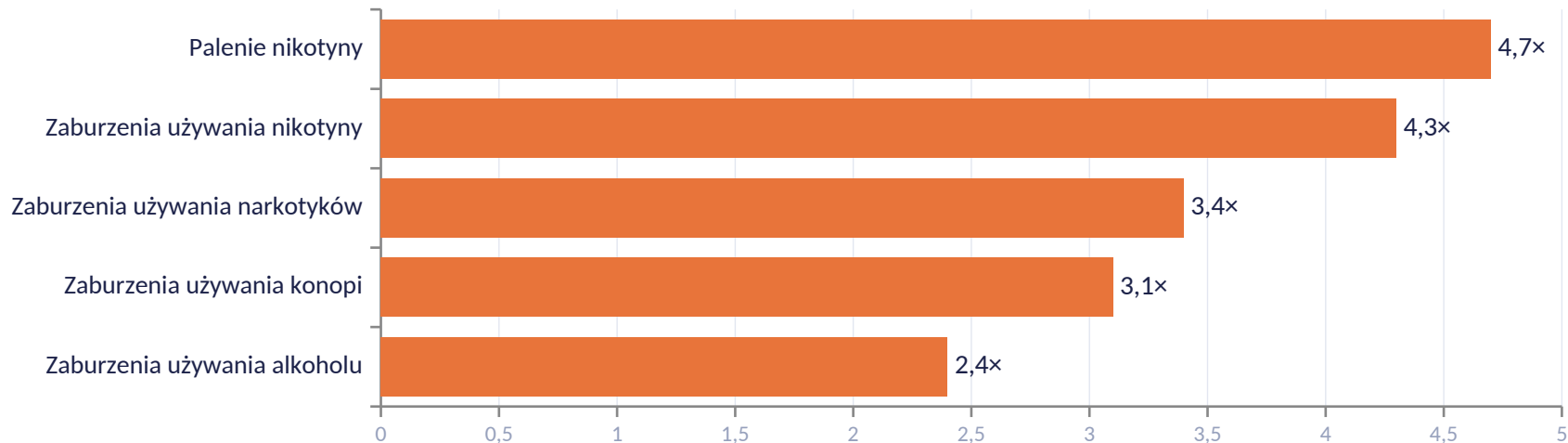
*Niekorzystny przebieg życiowy wynika z nakładania się ADHD i moderatorów ryzyka*



*Najbardziej ostrożny wniosek: ADHD zwiększa prawdopodobieństwo cięższego przebiegu, gdyż rokowanie zależy też od współchorobowości i środowiska.*

# ADHD silnie zwiększa ryzyko zaburzeń używania substancji

Względne ryzyko (RR) w prospektywnych badaniach kohortowych — ujęcie syntetyczne



Źródło: opracowanie syntetyczne na podstawie Lee et al. (2011), *Clinical Psychology Review*; Charach et al. (2011), *JAACAP*.

wcześniejszy początek używania

większa wielosubstancyjność

trudniejsze leczenie  
i więcej nawrotów

# Sześć dróg prowadzących od ADHD do uzależnienia

*Mechanizmy nie są rozłączne, mogą się więc wzajemnie wzmacniać*

| Mechanizm                           | Możliwa konsekwencja                                                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Impulsywność                        | Szybsze rozpoczęcie używania i większe ryzyko nawrotu pod wpływem bodźca |
| Preferencja natychmiastowej nagrody | Przewaga krótkotrwałej ulgi nad odległymi korzyściami abstynencji        |
| Poszukiwanie stymulacji             | Wybieranie silnie wzmacniających zachowań i substancji                   |
| Dysregulacja emocji                 | Używanie substancji jako sposobu redukcji napięcia i dysforii            |
| Dysfunkcje wykonawcze               | Trudności z planem leczenia, terminami i zapobieganiem nawrotom          |
| Współchorobowość                    | Kumulacja ryzyka wynikająca z depresji, zaburzeń zachowania i traumy     |

**Hipoteza samoleczenia:** krótkotrwała subiektywna ulga (napięcie, bezsenność, dysforia, chaos poznawczy) nie oznacza, że substancja „leczy” ADHD — bywa okupiona nasileniem problemów poznawczych, emocjonalnych i społecznych w dłuższej perspektywie.

# ADHD utrudnia leczenie już rozwiniętego uzależnienia

*Złożoność przebiegu, nie pewność każdego nawrotu*

## Bariery terapeutyczne

- Nieregularne uczęszczanie na terapię
- Zapominanie o wizytach
- Słaba realizacja zadań terapeutycznych
- Impulsywne nawroty
- Trudności w planowaniu sytuacji wysokiego ryzyka
- Gorsze przestrzeganie farmakoterapii

## Profil kliniczny ADHD + SUD

- Wcześniejszy początek używania
- Większa liczba używanych substancji
- Więcej problemów psychiatrycznych
- Więcej problemów społecznych i prawnych

# Czy farmakoterapia ADHD zwiększa ryzyko uzależnienia?

*Dostępne dane nie potwierdzają wzrostu ryzyka przy prawidłowym leczeniu*

## ✓ Brak dowodów wzrostu ryzyka

W badaniach populacyjnych leczenie stymulantami nie wiązało się ze wzrostem ryzyka SUD; część analiz wskazuje na niższą częstość zdarzeń związanych z używaniem w okresach leczenia.

## Kluczowe jest rozróżnienie

Kontrolowane przyjmowanie leku ≠ pozamedyczne stosowanie, przekazywanie leków innym osobom czy zmiana drogi podania.

### Strategie u pacjentów wysokiego ryzyka nadużywania

Preparaty długo  
działające

Leki niestymulujące

Ograniczona liczba  
wydawanych dawek

Monitorowanie  
i nadzór



## Leczenie współwystępujących ADHD i SUD: model równoległy

*Farmakoterapia ADHD poprawia objawy, ale rzadko wystarcza jako leczenie samego SUD*



*W nowszych dużych analizach rejestrowych rozpoczęcie leczenia ADHD wiązało się z niższą częstością pierwszego epizodu nadużywania substancji. Jednak obserwacyjny charakter tych wyników wymaga ostrożności interpretacyjnej.*

# Współchorobowość psychiatryczna jest regułą, nie wyjątkiem

Systematyczny przegląd: wyższa częstość zaburzeń nastroju, lękowych, ChAD, SUD i osobowości w ADHD

| Obszar                  | Znaczenie kliniczne                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Depresja                | Zwiększa niesprawność, ryzyko uzależnień, bezrobocia i zachowań samobójczych |
| Zaburzenia lękowe       | Mogą maskować ADHD i dodatkowo pogarszać uwagę oraz unikanie zadań           |
| Zaburzenie dwubiegunowe | Wymaga różnicowania przewlekłych objawów ADHD od epizodów manii/hipomanii    |
| Zaburzenia zachowania   | Silnie wzmacniają związek z uzależnieniami, agresją i przestępczością        |
| Zaburzenia osobowości   | Zwiększają ryzyko niestabilności relacji, samouszkodzeń i problemów prawnych |
| Zaburzenia snu          | Nasilają nieuwagę, drażliwość i problemy z regulacją emocji                  |

Źródło: Choi et al. (2022), PLOS ONE — systematyczny przegląd populacji ADHD vs. bez ADHD.

Wielkości związków różnią się zależnie od populacji i kryteriów diagnostycznych — tabela przedstawia kierunek i kliniczną wagę zależności, nie uniwersalne ryzyko dla pojedynczej osoby.

# Depresja, lęk i ChAD

*Nakładanie objawowe wymaga uwagi na przebieg czasowy*

## Depresja

- Może rozwijać się wtórnie do niepowodzeń, krytyki, odrzucenia i utraty pracy
- Współwystępowanie z ADHD wiąże się z cięższym upośledzeniem i wyższym ryzykiem samobójczym

## Zaburzenia lękowe

- Może wynikać z chronicznego braku kontroli nad terminami i obowiązkami
- Zarówno lęk, jak i depresja mogą pogarszać uwagę, a to komplikuje diagnostykę

## Choroba afektywna dwubiegunowa

- Nakładanie objawowe: impulsywność, rozpraszalność, szybka mowa
- Kluczowy jest przebieg czasowy - ADHD przewlekłe, mania/hipomania epizodyczna

*Błędne rozpoznanie ChAD u osoby z przewlekłym ADHD (lub odwrotnie) może prowadzić do niewłaściwego leczenia farmakologicznego.*

# Zaburzenia zachowania i osobowości jako moderatory ryzyka

*Największe ryzyko przestępczości i uzależnień dotyczy konkretnej konfiguracji cech*

## Zaburzenia zachowania → ASPD

- **Najważniejszy moderator** związku ADHD z przestępczością i uzależnieniami
- **Największe ryzyko:** wczesna agresja, uporczywe naruszanie norm
- **Późniejsze cechy antyspołeczne** najsilniej nasilają ryzyko

## ADHD, a osobowość borderline

- **Wspólny mianownik:** impulsywność i dysregulacja emocjonalna
- **BPD dodaje:** utrwaloną niestabilność relacji i obrazu siebie
- **BPD dodaje:** silną wrażliwość na odrzucenie

## Podwyższone ryzyko zachowań samobójczych i przedwczesnej śmierci

*Ryzyko jest w dużej mierze wyjaśniane przez czynniki współwystępujące*

### Co podwyższa ryzyko?

- Myśli i próby samobójcze, zatrucia, wypadki
- Przedwczesna śmierć z przyczyn nienaturalnych
- Znaczną część ryzyka wyjaśniają: depresja, SUD, impulsywność, konflikty i problemy ekonomiczne

### Leczenie ADHD

może obniżać częstość zdarzeń samobójczych i zgonów z przyczyn nienaturalnych. Jest to wynik biologicznie i psychologicznie wiarygodny (lepszą kontrola impulsów), oparty na badaniach rejestrowych

Powyższe dane mają charakter epidemiologiczny i nie zastępują bezpośredniej, indywidualnej oceny ryzyka samobójczego u konkretnego pacjenta.

# Nadreprezentacja ADHD w populacjach penitencjarnych

*Nadreprezentacja nie jest równoznaczna z przestępczością*

ADHD jest znacznie częstsze w populacjach więziennych niż w populacji ogólnej. Szacunki różnią się zależnie od wieku, kraju i metody diagnostycznej, a badania oparte wyłącznie na kwestionariuszach przesiewowych zwykle wskazują wyższą częstość niż pełne badania kliniczne.

**Co naprawdę decyduje o ryzyku?**

Współwystępujące  
zaburzenia  
zachowania

Zaburzenia  
używania  
substancji (SUD)

Ubóstwo  
i bezrobocie

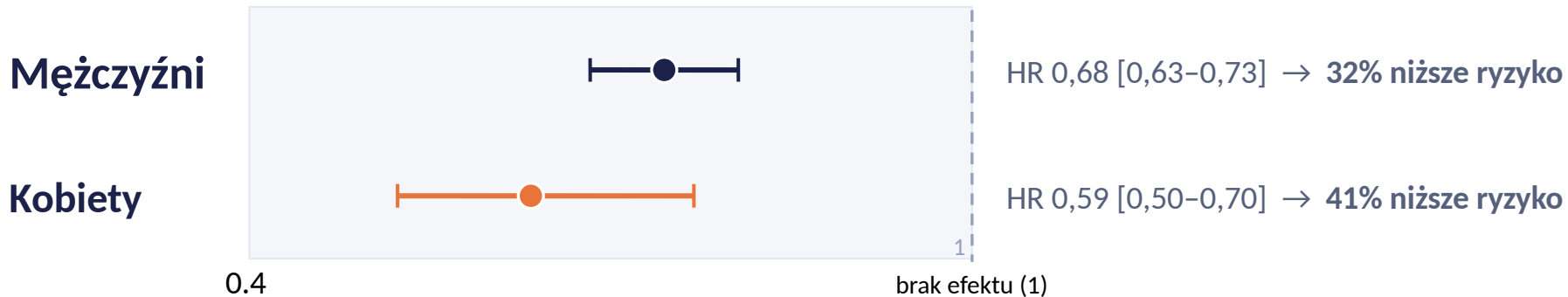
Niepowodzenia  
szkolne

Ekspozycja na  
środowiska  
wysokiego ryzyka

**ADHD samo w sobie nie tłumaczy przestępczości, ale wyjaśnia ją kumulacja czynników ryzyka**

## Farmakoterapia ADHD, a ryzyko skazania

Badanie rejestrowe (Szwecja): analiza wewnątrz-osobnicza: te same osoby w okresach leczenia i bez leczenia



**N = 25 656** osób z ADHD  
porównanie tych samych osób  
w okresach leczenia i bez leczenia

Konstrukcja wewnątrz-osobnicza ogranicza wpływ stałych cech jednostki, ale nie eliminuje wszystkich zmiennych zależnych od czasu

# Edukacja: rozbieżność między potencjałem a realizacją

*Trudności nie wynikają przede wszystkim z niższej inteligencji*

## Obserwowane konsekwencje

- Niższe oceny i większa absencja
- Częstsze powtarzanie klasy
- Większe wykorzystanie wsparcia specjalistycznego
- Wyższe ryzyko przerwania edukacji

## Co naprawdę pomaga

- Farmakoterapia poprawia uwagę i hamowanie reakcji
- ...lecz wpływ na wyniki edukacyjne jest mniejszy niż na same objawy
- Najlepsze efekty: leczenie + trening organizacji + zewnętrzne terminy + dostosowania edukacyjne

*Kluczowa jest rozbieżność między potencjałem, a zdolnością do systematycznej realizacji długotrwałych, wieloetapowych zadań.*



## Praca: bezrobocie, rotacja i prezenteizm

*Prezenteizm — formalna obecność przy obniżonej wydajności*

### Typowe trudności w dorosłości

- Zwiększone ryzyko bezrobocia
- Częste zmiany pracy, spóźnienia
- Prezenteizm: przełączanie zadań, odwlekanie, naprawianie błędów
- Konflikty i praca poniżej kwalifikacji

### ADHD nie wyklucza wysokich osiągnięć

- Środowiska dynamiczne i autonomiczne
- Szybkie informacje zwrotne
- Praca zgodna z silnymi zainteresowaniami

*Ryzyko rośnie w pracy monotonnej, słabo ustrukturyzowanej, wymagającej wielomiesięcznego samodzielnego planowania*

## Zwiększone ryzyko wypadków i zachowań ryzykownych

*Mechanizm: rozproszenie uwagi, impulsywność i poszukiwanie stymulacji*

**Wypadki  
komunikacyjne**

**Urazy i zatrucia**

**Ryzykowne  
zachowania  
seksualne**

**Nieprzestrzeganie  
zaleceń  
medycznych**

Mechanizm obejmuje rozproszenie uwagi, impulsywność, poszukiwanie stymulacji i trudności w utrzymaniu rutyn bezpieczeństwa.

*Badania rejestrowe: w okresach leczenia ryzyko części zdarzeń transportowych jest niższe, choć nie dla wszystkich typów urazów wyniki są jednoznaczne.*

# Sprzężenie zwrotne konfliktu w relacji partnerskiej

Objaw ADHD bywa odczytywany jako obojętność albo brak szacunku



# ADHD w rodzinie: rodzic, dziecko i budżet domowy

*Efekty wielu drobnych trudności kumulują się w codziennym funkcjonowaniu*

## ADHD u rodzica

- Park et al. (2017), 32 badania: wyższe nasilenie rodzicielstwa surowego i niekonsekwentnego
- Efekty małe, lecz kumulujące się w codziennych rutynach
- Znaczenie mają stałe rutyny i wsparcie drugiego opiekuna

## ADHD u dziecka

- Większy przeciętny stres rodzicielski
- Niedobór snu, ograniczenie pracy zawodowej
- Mniejsza dostępność rodziców dla rodzeństwa i możliwe też efekty pozytywne (empatia)

## Finanse rodziny

- „Podatek wykonawczy ADHD”: impulsywne zakupy, mandaty, nieterminowe opłaty
- Niewykorzystane subskrypcje, zgubione przedmioty
- Koszt wynika z trudności w przekładaniu intencji na działanie, nie z braku wiedzy

## KOSZTY SPOŁECZNE

# Koszty społeczne ADHD liczone są w miliardach dolarów

Wydatki bezpośrednie i pośrednie, a w dużej mierze poza systemem psychiatrycznym

**122,8 mld \$**

nadwyżkowe koszty społeczne ADHD  
u dorosłych w USA, 2018 r.

**14 092 \$**

średni koszt przypadający na jedną  
dorosłą osobę z ADHD rocznie

**143–266 mld \$**

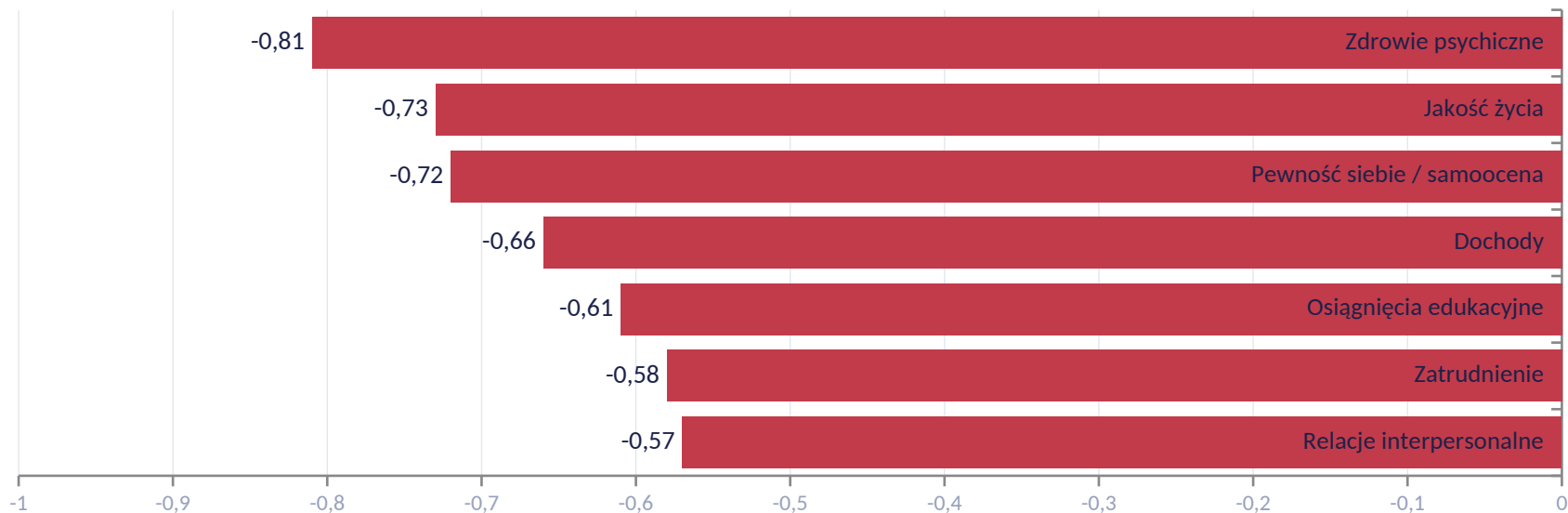
roczny koszt łączny: dzieci, dorośli  
i ich rodziny (Doshi et al., 2012)

| Kategoria               | Przykładowe składowe                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona zdrowia         | Diagnoza, leki, konsultacje, hospitalizacje, leczenie SUD i urazów            |
| Edukacja i praca        | Wsparcie specjalistyczne, powtarzanie klasy, absencja, prezentyzm, bezrobocie |
| Rodzina, wypadki, prawo | Obciążenie opiekunów, leczenie urazów, policja, sądy, więziennictwo           |

*Dla Polski nie istnieje obecnie równie pełne oszacowanie — mechaniczne przeliczenie kosztów USD na PLN byłoby niepoprawne metodologicznie.*

# Osoby z ADHD osiągają systematycznie gorsze wyniki życiowe

Faraone et al. (2021) — 86 badań, N = 2 639 438 (dzieci, młodzież i dorośli)



Cohen's d (wartości ujemne = wyniki gorsze niż u osób bez ADHD)

• interpretacja: 0,2 mały • 0,5 umiarkowany • 0,8 duży efekt

# Leczenie wielomodalne: co działa, a co wymaga więcej dowodów

*Najsilniejsze dowody dotyczą redukcji objawów. Dla wyników funkcjonalnych efekty są mniejsze, ale klinicznie istotne*

## Składowe modelu

- Farmakoterapia dobrana do profilu ryzyka
- Psychoedukacja pacjenta i rodziny
- Terapia poznawczo-behawioralna
- Trening funkcji wykonawczych
- Leczenie współchorobowości i SUD
- Interwencje rodzinne
- Dostosowania edukacyjne i zawodowe
- Leczenie zaburzeń snu

## Synteza dowodów wg obszaru

| Obszar                 | Ocena dowodów                         |
|------------------------|---------------------------------------|
| Objawy ADHD            | Silne dowody poprawy                  |
| Uzależnienia           | Brak wzrostu ryzyka; możliwa redukcja |
| Przestępczość          | Umiarkowanie silne dowody redukcji    |
| Wypadki transportowe   | Prawdopodobna redukcja                |
| Zachowania samobójcze  | Prawdopodobna redukcja (rejstry)      |
| Edukacja               | Mała-umiarkowana poprawa              |
| Zatrudnienie / dochody | Możliwa poprawa, dane słabsze         |
| Relacje i rodzina      | Możliwa poprawa + interwencje         |
| Recydywa               | Dane ograniczone                      |

# Klasy leków i ich porównawcza skuteczność

Metaanaliza sieciowa 133 RCT, dzieci i młodzież, SMD względem placebo (ocena klinicystów)



| Klasa                  | Mechanizm                             | Charakterystyka                             |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Metylofenidat          | Hamowanie wychwyty DA/NA              | Szybki początek, liczne postacie uwalniania |
| Amfetaminy             | ↑ uwalnianie i ↓ wychwyt katecholamin | Najwyższa skuteczność objawowa; bezsenność  |
| Atomoksetyna           | Hamowanie transportera NA             | Brak typowego potencjału nadużywania        |
| Guanfacyna / klonidyna | Modulacja receptorów α2A              | Mniejsza skuteczność; przydatne przy tikach |

Źródło: Cortese, S., et al. (2018). The Lancet Psychiatry, 5(9), 727–738. Metylofenidat preferowany jako pierwsza opcja u dzieci (bilans skuteczności i tolerancji).



# Monitorowanie leczenia i ograniczenia interpretacyjne

*Częste działania niepożądane nie są porównywalne head-to-head między preparatami*

## Najczęstsze działania niepożądane

- MPH OROS:  
ból głowy 22%, ↓ apetytu 15%, ból brzucha 14%
- Atomoksetyna:  
nudności 26%, ból brzucha 18%, ↓ apetytu 16%
- Guanfacyna ER:  
senność 38%, ból głowy 24%, zmęczenie 14%

## Ograniczenia interpretacyjne

- Brak wieloletnich RCT z randomizacją do leczenia / braku leczenia
- Dane o przestępczości, śmiertelności i kosztach są w dużej mierze obserwacyjne
- Heterogeniczność ADHD: płeć, wiek, współchorobowość, środowisko
- HR / OR ≠ bezwzględne prawdopodobieństwo zdarzenia u jednej osoby

*Wyniki grupowe nie pozwalają przewidzieć losu konkretnej osoby, dlatego interpretacja kliniczna pozostaje niezbędna*

## WNIOSKI

# ADHD wymaga wczesnej, kompleksowej interwencji

- 1 ADHD silnie zwiększa ryzyko uzależnień, lecz prawidłowo prowadzona farmakoterapia tego ryzyka nie zwiększa.
- 2 **Najgorszy przebieg dotyczy konfiguracji:**  
ADHD + zaburzenia zachowania/ASPD + depresja lub SUD + niekorzystne środowisko + brak leczenia
- 3 Leczenie wiąże się z niższym ryzykiem przestępczości, wypadków transportowych i zachowań samobójczych
- 4 **Koszty społeczne ADHD** liczone są w setkach miliardów dolarów rocznie
- 5 Wczesne, wielomodalne leczenie to nie tylko redukcja objawów, lecz potencjalna profilaktyka uzależnień, wypadków i marginalizacji.

---

*Funkcjonalne konsekwencje ADHD rozciągają się od działania neuronu po budżet państwa, ale to wczesna, kompleksowa interwencja decyduje o tym, w którą stronę przechylą się ten bilans.*